

УДК:618.16-036.22(574)

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
Р.Ш. Шалбаева, М.Р. Кайрбаев, Э.К. Макимбетов

Заболееваемость раком вульвы в Республике Казахстан

Аннотация. Цель исследования: изучить заболееваемость раком вульвы (РВ) в Республике Казахстан.

Материал и методы. Изучены 852 случая, зарегистрированных впервые по поводу РВ с 2003 по 2012 гг. Источником информации явились данные полученные из специализированных и неспециализированных учреждений страны. Подсчитаны грубые и стандартизованные (мировой стандарт) показатели заболееваемости РВ по возрасту.

Основные результаты. Среднегодовой средний возраст пациенток РВ составил $70,8 \pm 0,3$ лет. Интенсивный или грубый показатель заболееваемости РВ женского населения республики за исследуемый период времени, подсчитанный на 100 тысяч, составил 0,9. При подсчете стандартизованных показателей заболееваемости по мировому стандартному населению было выявлено, что данный показатель заболееваемости РВ был равен 1,0 на 100 тысяч, при 95% ДИ 0,8 – 1,0. При этом темп прироста за 10 лет составил 12,6%.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о возрастной вариабельности рака вульвы у женщин.

Актуальность

Рак вульвы (РВ) является относительно редким злокачественным заболеванием и среди опухолей женских половых органов занимает четвертое место (после рака шейки матки, тела матки и яичников), составляя 3–8%. Заболееваемость не превышает 3,0 на 100 000 женщин, с небольшими географическими колебаниями [1]. В экономически развитых странах мира заболееваемость РВ равна 2,0 – 3,0 на 100 тысяч популяции и составляет 4% от всех злокачественных гинекологических опухолей. Показатели заболееваемости в 10 раз выше среди женщин старше 75 лет, достигая 20/100 000 [2, 3]. Наиболее высокие уровни зарегистрированы в развивающихся странах и наблюдается тенденция к омоложению болезни [4]. Относительно низкие показатели заболееваемости отмечены среди женщин Китая, Японии, Кореи и азиатских женщин, проживающих в США [5]. Во многих странах, в том числе в странах СНГ, получить информацию о частоте РВ трудно, т.к. данная опухоль объединяется с образованиями влагалища и другими [6]. В Российской Федерации стандартизованный показатель заболееваемости РВ составляет 1,3 – 1,4‰ [7-9].

Международная федерация гинекологов и акушеров (FIGO) приводит невысокие результаты (не более 50% для всех стадий) пятилетней выживаемости [4]. РВ также сопровождается тяжелыми физиологическими и психологическими последствиями для пациентки. Это обуславливает актуальность исследования. Несмотря на

то что, этиология и патогенез РВ изучены недостаточно, в последние годы большое внимание уделяется вирусной инфекции, обусловленной человеческим папилломавирусом [3].

Гистологически РВ в 90% и более представлен плоскоклеточным вариантом. Реже встречаются меланома, аденокарцинома, рак Бартолиновой железы, саркома.

Цель исследования

– изучить по возрастной заболееваемость раком вульвы в Республике Казахстан.

Материал и методы исследования

Материалом исследования явились 852 пациентки, зарегистрированных впервые по поводу РВ за 10 лет (с 2003 по 2012 гг.). Источником информации явились данные полученные из специализированных и неспециализированных онкологических учреждений страны. Подсчитаны грубые и стандартизованные (мировой стандарт) показатели заболееваемости РВ. Были использованы статистические методы исследования по изучению заболееваемости РВ на основании специальной Инструкции (ИНСТРУКЦИЯ по составлению «Отчета о заболеваниях злокачественными новообразованиями» (форма №7), утвержденная Приказом Агентства РК по статистике от 28.05.2003г. №12-г). Учет осуществлялся на основе заполнения учетной формы «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования» - форма №090/у (утвержденная Приказом Минздрава РК № 437 от 20.10.1993г.).

В областных (региональных) и городских онкологических диспансерах осуществлялся контроль за поступлением «Извещений» из организаций других ведомств, а также посмертно выявленных заболеваний путем сопоставления данных с материалами ЗАГСов.

Каждый зарегистрированный случай РВ был снабжен данными численности популяции изучаемого региона. При этом также использованы сведения о численности взрослого населения в возрастных группах (15-19, 20-24, 25-29 ...80-84, 85 и более лет).

Статистическая обработка данных производилась на основе использования стандартных математических программ, используемых в медико-биологической статистике.

Результаты исследования

В возрастной группе 0-29 лет было выявлено 9 случаев РВ (1,1%), в группе 30-39 лет – 23 случая (2,7%), в 40-49 лет – 62 (7,3%). Наибольшее количество больных РВ было

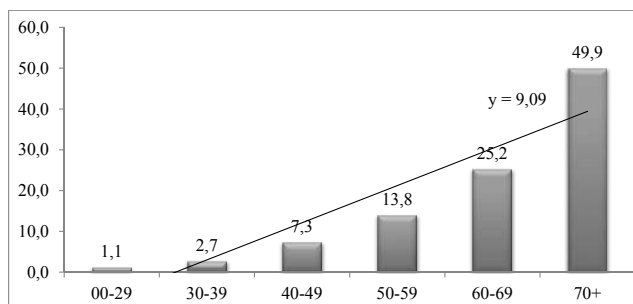


Рисунок 1 - Средний удельный вес пациенток раком вульвы по возрастам в Республике Казахстан (2003-2012 гг.)

зарегистрировано в самой старшей возрастной группе, т.е. у пожилых (70 лет и старше) – 425 случаев (49,9%). На втором месте по частоте находилась возрастная группа 60-69 лет (215 случаев – 25,2%). И на третьем месте были пациентки возрастной группы 50-59 лет – 118 (13,8%) случаев (рисунок 1).

В динамике по годам исследования было выявлено, что абсолютное число пациенток РВ было неодинаковым, так, наименьшее число пациенток было зарегистрировано в 2002 году – 32 случая, а наибольшее – в 2012 г. (110 случаев).

Среднегодовой средний возраст пациенток РВ за исследуемый период времени по республике составил $70,8 \pm 0,3$ лет, при 95% ДИ 70,2 – 71,3. При рассмотрении в динамике отмечалось снижение значения среднего возраста с момента начала исследования на 10%.

Интенсивный или грубый показатель заболеваемости РВ женского населения республики за исследуемый период времени, подсчитанный на 100 тысяч соответствующей популяции, увеличивался с возрастом пациенток (рисунок 2). Если интенсивный показатель заболеваемости РВ в 30-39 лет был равен 0,2, то в 40-49 лет – 0,6, в 50-59 лет – 1,5 на 100 тысяч. Резкий подъем уровней интенсивных показателей заболеваемости РВ наблюдался с 60-69 лет, когда он достиг 4,1 на 100 тысяч. Самый высокий интенсивный показатель заболеваемости был зарегистрирован у пациенток пожилого возраста (70 лет и старше) и равен 9,0 на 100 тысяч. В целом, грубый или интенсивный показатель заболеваемости РВ за исследуемый период времени (2003 – 2012 гг.) был отмечен на уровне $1,0 \pm 0,1$, при 95% ДИ 0,9 – 1,2.

При подсчете стандартизации показатель заболеваемости РВ был равен $0,9 \pm$ на 100 тысяч (95% ДИ 0,8 – 1,0), а темп прироста составил 12,6%.

Как видно из представленного рисунка 3 видно, что темпы и динамика средних значений стандартизованных и интенсивных показателей заболеваемости РВ в Казахстане не совпадали.

Стандартизованные показатели имели несколько сниженные уровни, чем грубые или интенсивные показатели.

Заключение

За исследуемый период времени в Республике Казахстан было зарегистрировано 852 пациентки раком вульвы. Половину всех зарегистрированных составили пациентки РВ пожилого возраста (70 лет и старше). Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости раком вульвы в Казахстане составил 1,0, а стандартизованный по мировому стандартному населению 0,9 на 100 тысяч популяции. В возрастной группе 70 лет и старше зарегистрирован самый высокий

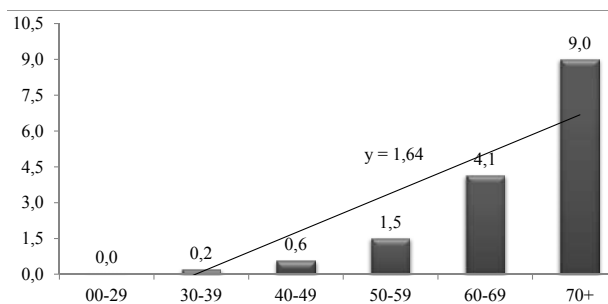


Рисунок 2 - Интенсивный показатель заболеваемости раком вульвы в Республике Казахстан за 2003 – 2012 гг.

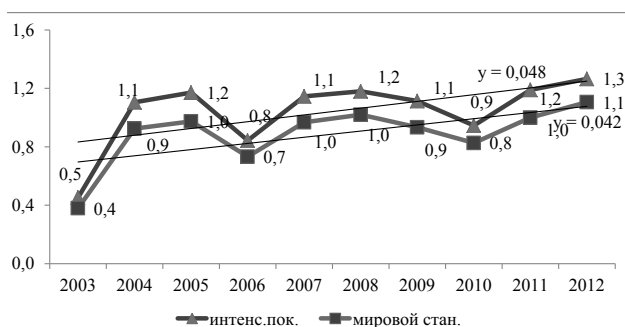


Рисунок 3 - Динамика и тренды интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости раком вульвы

уровень заболеваемости раком вульвы – 9,0 на 100 тысяч соответствующей популяции. В динамике темпы интенсивных и стандартизованных показателей в целом совпадают. Полученные данные о возрастной вариативности рака вульвы вызывают необходимость проведения дальнейших исследований с использованием аналитических методов, таких как когортных и случай-контрольных. Это позволяет выявить определенные факторы риска в патогенезе рака вульвы и разработать профилактические мероприятия.

Список использованной литературы

1. D.M. Parkin, Whelan S.L., J. Ferlay, et al. *Cancer Incidence in Five Continents. Vol. VIII, IARC Scientific Publications No. 155.* Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. - 2002. – 230 p.
2. J.S. Carter. *Vulvar and vaginal cancer // Obstetrics & Gynecology Clinics of North America.* – 2012. V.39. – P.213.
3. А.Ф. Урманчеева. Эпидемиология рака вульвы, факторы риска и прогноза // *Практическая онкология.* – 2006. – Т.7, №4. – С.189-196.
4. K.C. Fuh. *Current management of vulvar cancer // Hematology-Oncology Clinics of North America.* – 2012. – Vol.3. – P.45.
5. C. Bodelon, M.M. Madeleine, L.F. Voigt et al. *Is the incidence of invasive vulvar cancer increasing in the United States? // Cancer Causes Control.* – 2009. – Vol. 20(9). – P. 1779–1782.
6. Ж.А. Арзыкулов, Г.Д. Сейтказина, С.И. Игисинев и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* – Алматы, 2003- 2010.
7. В.М. Мерабишвили. *Злокачественные новообразования в мире.* – СПб, 2007. – С.9-10.
8. В.И. Чиссов, В.В. Старинский. *Состояние онкологической помощи населению Российской Федерации.* – М., 2006. – С.66-68.
9. В.И. Чиссов, В.В. Старинский, Б.Н. Ковалев и др. *Стратегия и тактика онкологической службы России на Современном этапе // Российский онкологический журнал.* – 2006. – №3. – С.4-7.

ТУЖЫРЫМ

Р.Ш.Шалбаева, М.Р.Қайрабаев, Э.К.Макимбетов

«Қазақстан Республикасындағы вульва қатерлі ісік сырқаты»

Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасында вульваның қатерлі ісік сырқатын анықтау.

Материалдар мен әдістер: 2003 және 2012 жылдар арасында вульваның қатерлі ісік сырқатымен 852 жағдай алғаш тіркеліп зерттелді. Еліміздің мамандандырылған және мамандандырылмаған емдік мекемелерінен алынған мәліметтер информация көзі болып табылады. Вульваның қатерлі ісігінің стандарталған (әлемдік стандарт) және өрескел көрсеткіші жас бойынша есептелді.

Негізгі нәтижесі: вульваның қатерлі ісік сырқаты науқастардың орташажылдық жасы $70,8 \pm 0,3$ орта жасты құрайды. Вульваның қатерлі ісік сырқатының қарқынды және өрескел көрсеткіші Республикалық әйел халқының зерттеу кезеңі уақытымен есептелген 100 мыңға, $0,9$ құрайды. Халықтың әлемдік стандарты бойынша стандарталған ауру көрсеткішін есептеу кезінде вульваның қатерлі ісік ауру көрсеткіші 100 мың халыққа $1,0$ тең болды, 95% кезінде сенімді аралық (ДИ) $0,8-1,0$ тең. Сонымен 10 жыл ішінде сырқаттын өсу қарқыны

- $12,6\%$ тең болды.

Қортынды: әйелдердегі вульва қатерлі ісігінің жас айырмашылық өзгеруін алынған деректер дәлелдейді.

Resume

Objective: to study of vulvar cancer (VC) incidence in the Republic of Kazakhstan.

Material and methods. Studied 852 cases of VC firstly registered since 2003 to 2012. Source of information data were obtained from specialized and non-specialized institutions in the country. Calculated crude and standardized (world standard) age specific incidence rates of VC.

Main results. The average annual mean age of patients with VC 70.8 ± 0.3 years. Crude or intensive rate incidence of VC was 0.9 on $100\,000$ female population during the study period. In calculating the standardized incidence rates for world standard population was found that the incidence rate of VC was equal to 1.0 per $100\,000$ (95% CI $0.8 - 1.0$). A growth rate of VC in 10 years was 12.6% .

Conclusion. The findings suggest that age-related variability of vulvar cancer in women.